

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

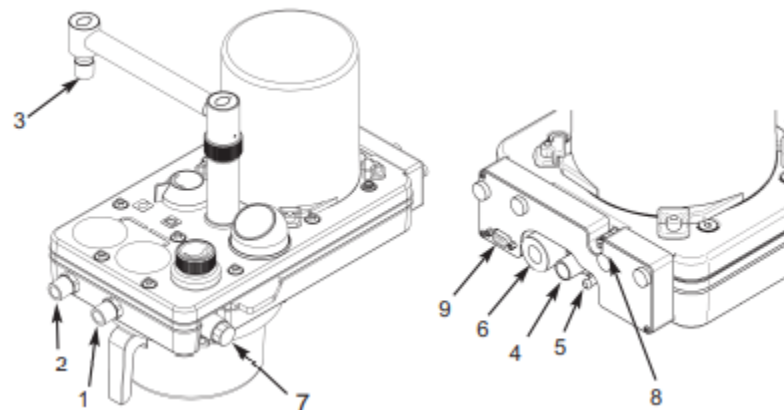


MAQUINA DE ANESTESIA

MARCA: PENLON
MODELO: PRIMA SP2

Recomendaciones antes de usar

- Revise por daños visibles, compruebe la estabilidad del equipo y la condición de las mangueras de suministro de gas.
- Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro eléctrico y de gas.
- Verifique el suministro adecuado del cilindro de respaldo.
- Verifique la correcta conexión y funcionamiento de los vaporizadores.
- Verifique el funcionamiento de la descarga de oxígeno.
- Compruebe la integridad del circuito paciente.



No.	Nombre	No.	Nombre
1	Conector de inspiración	6	Salida de escape de la válvula APL
2	Conector de expiración	7	Sensor de monitor de oxígeno
3	Conector de la bolsa	8	Salida: línea de muestra al puerto del monitor de presión en el ventilador
4	Entrada desde la salida DRIVE GAS del ventilador	9	Cable de interfaz: interruptor de bolsa/ventilación y espirometro
5	Entrada: manguera de gas fresco desde la salida común de gas.		

Símbolos



Modo adulto



Modo bolsa



Modo pediátrico



Suspiro

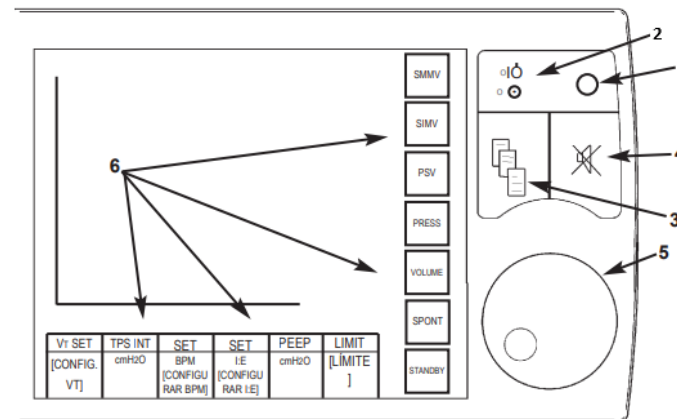
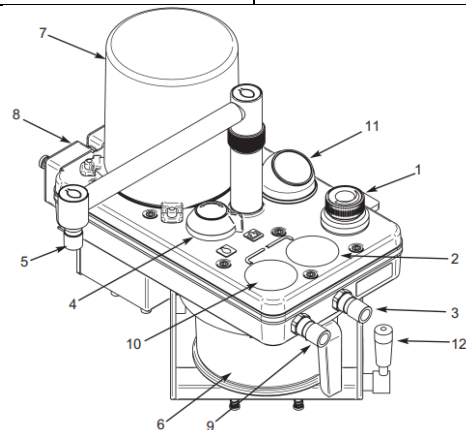


Modo ventilador



Pausa inspiratoria

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	



No.	Parte	No.	Parte
1	Válvula APL	7	Carcasa de fuelle del ventilador
2	Válvula inspiratoria de no retorno (NRV)	8	Unidad de interfaz eléctrica
3	Conector de manguera inspiratoria	9	Conector de manguera espiratoria
4	Interruptor de bolsa/ventilador	10	Válvula espiratoria de no retorno (NRV)
5	Conector de bolsa de depósito	11	manómetro
6	Canister	12	Palanca de liberación del canister

No.	PARTE	No.	PARTE
1	Control On/Off	4	Interruptor enmudecedor de alarma
2	Indicadores de estado para corriente eléctrica	5	Mando de navegación y botón pulsador
3	Interruptor de menú	6	Pestañas activas.

Pre-test:

1. Ajuste un circuito del paciente al conector inspiratorio (1) y espiratorio (2) en el absorbedor y conecte una bolsa al conector del brazo para la bolsa (3).
2. Coloque el interruptor de la bolsa/ventilador (4) en “Bag”.
3. Cierre la válvula APL (5) y ocluya el puerto de conexión del paciente en el circuito paciente. Presione brevemente el botón de la válvula de descarga de oxígeno en el frente de la máquina. Compruebe que la bolsa del depósito se infla y el manómetro (6) indica aproximadamente 40 cmH₂O.
4. Libere la válvula de descarga de oxígeno. Compruebe que se mantiene la presión en el sistema con menos de 200 ml/min de gas fresco suministrado al sistema de respiración, lo que demuestra que no hay fugas
5. Si esta prueba falla, verifique el sistema de baja presión en la máquina. Si la prueba de baja presión de la maquina tiene éxito, verifique el ventilador y el absorbedor consultando el manual de instrucciones del usuario correspondiente.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E		CÓDIGO			
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO		FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO

Modos de operación:

Modo de volumen:

- Presione la tecla de pantalla: “CONTROL DE VOLUMEN”.
- Si debe cambiar desde el modo Presión: Seleccione la tecla “CONTROL VOLUMEN” → El ventilador continuara ventilando en modo presión, pero en pantalla se mostrarán la configuración anterior o la configuración por defecto → Puede configurar un nuevo valor de volumen si es necesario → Pulse para confirmar el cambio de modo y la nueva configuración → El ventilador cambiara a modo volumen.
- Toque la pestaña de pantalla para cambiar entre volumen corriente y volumen minuto.
- Para **configurar la pausa inspiratoria**: Pulse el botón de MENU → Seleccione Modos → Seleccione “Modos especiales” → Seleccione “Pausa inspiratoria activada/desactivada” → Seleccione un valor de tiempo en porcentaje entre el 0 y el 60% → Salga de los menús. En la pantalla aparecerá el símbolo  de pausas inspiratorias.
- Para **configurar la función suspiro**: Pulse el botón de menú → Seleccionar Modos → Seleccionar Modos especiales → Seleccionar “Habilitar suspiro on/off” → Seleccionar el cociente de suspiro a respiración → Girar el mando para seleccionar el valor necesario → Pulsar el mando para confirmar → Salir de los menús. En la pantalla aparecerá la leyenda “SUSPIRO” o “SIGH”.

Modo de presión:

- Seleccione el modo tocando la pestaña “**PRESION**” de la pantalla

- Si debe cambiar desde el modo Volumen: Presione la tecla de pantalla “PRESION” → El botón de presión parpadea y se muestra la configuración anterior de la presión o la configuración por defecto → Ajuste el valor de Presión objetivo si es necesario → Pulse para confirmar el cambio de modo y la nueva presión objetivo → En ventilador cambiara a modo Presión.
- El usuario puede cambiar la presión objetivo si lo ve necesario.
- Confirme el nuevo modo, el ventilador cambiara a modo presión.

Modo espontaneo (Ventilación obligatoria intermitente sincronizada):

- El modo espontaneo se puede configurar de 2 formas:
 - Al arrancar el ventilador selecciónelo.
 - Durante la ventilación, mueva el interruptor del ventilador/bolsa del absorbente a “Bolsa”. El ventilador cambiara a modo espontaneo.
- Si lo ve necesario, enmudezca la alarma de apnea por uno de los tiempos preestablecidos (entre 15 y 180 segundos) presionando el botón “enmudecer alarma” en la pantalla del ventilador.

Modo SIMV:

- Se puede acceder a este modo mediante la función de visualización en la pantalla táctil. Una vez seleccionado, aparecerá SIMV en la pantalla principal.
- El Vt se puede ajustar antes de confirmar el modo SIMV.
- La configuración de disparo es ajustable entre 0.7 y 4.0 L/min

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte	Limpieza
Superficie exterior	Use un paño humedecido en solución limpiadora y bien escurrido.
Ventilador (Parte externa)	- Limpie la superficie exterior con un trapo húmedo con una solución de limpieza. - Utilice una solución de detergente suave y tibia para la suciedad resistente. - Use una solución antiséptica o paños anti microbiales para remover la sangre. - Asegúrese de que todos los residuos de agentes de limpieza hayan sido removidos por completo después de la limpieza.
Ventilador (Pantalla táctil)	- Utilice un paño suave. - No use agentes abrasivos.
Absorbedor	- Limpie con un paño húmedo el bote, el recipiente absorbente, el sello y la placa de sellado para eliminar partículas de cal sodada siempre que se cambie el absorbente. - Lave el ensamblaje del absorbedor internamente con agua tibia y una solución de jabón, luego enjuague y seque al aire.
Circuito del paciente	Lavar con una solución tibia de agua y jabón, enjuague con agua tibia y seque al aire.

RECOMENDACIONES:

- Use agentes limpiadores recomendados por la institución
- Use una solución de detergente suave y agua tibia para eliminar la mugre resistente.
- Asegúrese que todos los residuos de agentes limpiadores han sido removidos del equipo.
- Las mangueras del sistema de respiración y otros componentes deben esterilizarse según los métodos recomendados por el fabricante.
- No limpie ningún componente en máquina de lavado automático.

ADVERTENCIAS:

- No use ningún solvente fuerte o agentes abrasivos.
- Evite mojar los conectores.
- No permita que el líquido se infiltre en áreas cerradas

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

NOMBRE	DESCRIPCION
Ventilador inoperativo (Vent inop)	Falla interna del sistema. Compruebe el registro de error. Puede deberse a un fallo en el solenoide del gas de alimentación, la válvula de control de flujo, la electrónica interna, la eléctrica interna o un error en el software.
Salida bloqueada	La presión positiva del sensor PEEP excede 120 cmH ₂ O debido a la salida de la válvula de escape bloqueada
Presión de alimentación baja	La presión de gas de alimentación suministrada en el interruptor de presión es de menos de 235 kPa
Presión de vía respiratoria baja	El sensor de presión de gas de alimentación de los fuelles no logra ver al menos el 75% del nivel objetivo.
Presión de gas de alimentación baja	La presión de gas de alimentación y la vía respiratoria llega al nivel mínimo (control de volumen)
Presión alta continua	PEEP + 10 cmH ₂ O para 1 ciclo o PEEP +5 cmH ₂ O para 3 ciclos.
Presión de vía respiratoria negativa	La presión del sistema de respiración excede -10 cmH ₂ O
Controlar el sensor de presión	
Volumen corriente bajo/alto	El valor medido excede o es inferior al límite de alarma establecido
Volumen minuto alto/bajo	El valor medido excede o es inferior al límite de alarma establecido.
Apnea	Respiración no detectada dentro de los 15 segundos del modo espontaneo
Falla de sensor de oxígeno	Sensor de control de oxígeno desconectado.
Falla de suministro de potencia CA	Falla de corriente de red.
Falla de potencia de batería	La batería esta desconectada o descargada debajo a un nivel crítico.
Potencia a punto de fallar	El ventilador está funcionando con batería y está a punto de descargarse
Alarma sonora e indicador visual	El flujo de oxígeno disminuye o se detiene por completo.